

Krankheit	Anamnese/Symptome	Status	Untersuchungen/ Abklärungen	Therapie	Kommentar
RACHEN					
Akute Tonsillitis (nur Tonsillen/Mandeln)	Hals-Sz., Odynophagie, Dysphagie, oft Reflexotalgie (beim Schlucken), meist unilateral., akut od. chron., Globusgefühl, ev. Fieber, AZ, Kopf-Sz., LK-Schwellung, klossige Sprache	Inspektion Mund + Rachen (weissl. nicht-konfl. Beläge >Stippchen, Schwellung Tonsillen, Rötung) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (Abszess) Ohr + Nase untersuchen	Tonsillenabstrich + Strepto-Test), ev. BE (LK, CRP), Fieber messen	AB (Augmentin, falls bakteriell), Lutschtabletten (Analgesie) NSAID ev.	In ersten 24h ansteckend (Tröpfchen). <u>Syn</u> : Angina tonsillaris/lacunaris <u>Erreger</u> : meist bakteriell (Strep. A), selten EBV (starke Beläge, Grippe-Symp., Müdigkeit, langer Verlauf)
Peritonsillarabszess, Parapharyngealabszess, Retropharyngealabszess	Meist i.R. od. nach akuter Tonsillitis od. Zahnproblem/behandlung, Hals-Sz., meist unilateral, Odyno- bis Dysphagie, Trismus, hohes Fieber, Aphagie, red. AZ <u>Retroph.Abszess</u> : Torticollis, Dyspnoe, weniger Sz als bei Para- oder Peritonsillärabszess	Inspektion Mund + Rachen (<u>Peri</u> : einseitige Rötung + Schwellung Uvula/Wiechgaumen+ hinter Tonsille mit Verlagerung Gaumensegel >Kulissenph., <u>Para</u> : enorale parapharyngeale Schwellung, <u>Retro</u> : enorale prävertebrale Schwellung). Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (ev. Schwellung + Sz.) Ohr + Nase untersuchen	Hospitalisation, PVK + BE (CRP, BSG, Linksversch.), Fieber <u>Peritonsillarabszess</u> : i.d.R. <u>klinische Dx</u> , CT (KM) möglich <u>Parapharyngealabszess</u> : CT (KM) <u>Retropharyngealabszess</u> : CT (KM) (US schlecht)	<u>Peritonsillarabszess</u> 1. Spaltung Abszess (Drainage) in LA + tgl. Spreizen + Spülen od. Abszess-TE (à Chaud), AB, Kontrollen! 2. Falls Spaltung TE nach 3 Mt. (à froid) empfohlen <u>Parapharyngealabszess</u> : Abszessdrainage (Spaltung) + ev. TE, AB (i.v.) <u>Retropharyngealabszess</u> : „“, AB i.v.	
Chron. Tonsillitis	Fibrosierung d. Tonsillen oft bei Rauchern, sz.-hafte vernarbte Tonsillen, zeigt s. als rezidiv. Tonsillitiden od. ohne Symptome, Abgeschlagenheit, Halitosis	Inspektion Mund + Rachen (kleine derbe Tonsillen, schlecht luxierbar, peritonsilläre Rötung) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals Ohr + Nase untersuchen	Labor (BSG + CRP erhöht, Linksverschiebung), Abstrich ev.	TE (falls Dx. klar und Pat.wunsch)	Rezidiv. Infekte d. Tonsillen >Fibrosierung
Akute Angina (ganzer Waldeyerscher Rachenring)	Hals-Sz., Odynophagie, Dysphagie, oft Reflexotalgie (beim Schlucken), akut od. chron., Globusgefühl, ev. Fieber, AZ, Kopf-Sz., LK-Schwellung	Inspektion Mund + Rachen (Rötung/Schwellung Rachen/Tonsillen/etc, ev. Beläge an Rachenhinterwand) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (Abszess) Ohr + Nase untersuchen	Rachen- + Tonsillenabstrich (Strepto-Test), ev. BE (LK, CRP), Fieber messen	AB (Augmentin, falls bakteriell), Lutschtabletten (Analgesie) NSAID ev.	

Akute Pharyngitis	Odynophagie, Hals-Sz., Symptome eines Infektes d. oberen Luftwege (LK, Fieber, Kopf-Sz., Husten, NAB)	Inspektion Mund + Rachen (Starke Rötung Rachen, ev. schleimige Beläge) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals Ohr + Nase untersuchen	Ev. Rachen-Abstrich	Kein Fieber: NSAID, Gurgeln (antisept.), Hausmittel , viel Trinken Fieber: AB (Augmentin) Ist fast immer banal! Häufig!	Oft viral (Influenza- od. Parainfl.-Viren), z.T. bakteriell Meist banale Pharyngitis! 50% d. Hals-Sz. wegen banaler Ph.
Chron. Pharyngitis	Räusperzwang, Reizhusten, FK-Gefühl, i.d.R. keine Hals-Sz. <u>RF</u> : Langfristige Exposition gg. noxen (Rauchen, Alk, Chemikalien, Reizgase), Mundatmung, chron. Sinusitis	Inspektion Mund + Rachen (granulierte od. ganz glatte Rachenhinterwand) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (Abszess) Ohr + Nase untersuchen	Endoskopie Nase (Septumdeviation, Muschelhyperplasie, etc.)	1. Noxen weg 2. Befeuchtung Atemwege (Inhalation >Salbei, super!), Lutschtabletten, Trinken 3. Operation (falls anatom. Problem)	
Scharlach	Hals-Sz., Odynophagie, Otalgie, Husten, hohes Fieber, LK, Exanthem (Rötung Zunge + Mund), Exanthem	Inspektion Mund + Rachen (initial weissl. belegt, dann Himbeerzunge, Tonsillen dunkelrot geschwollen, Rachen gerötet) Lymphknoten Inspektion + Palpation Hals (Abszess) Ohr + Nase untersuchen Haut : stecknadelkopf-grosses Exanthem	Strepto-Schnelltest Fieber messen	AB (Augmentin)	B-Hämolysierende Strept. A (wie Akute Tonsillitis)
Nekrotisierende Faszitis	Bleibt nicht in Logen drin, Gefahr einer Mediastinitis	Inspektion und Mund und Rachen, LK, Hals Inspektion und Palpation, Nase und Ohren untersuchen	CT/MRI	AB oder Notfallcervikotomie	
Tonsillennachblutung	Blutung aus Mund, ev. Bluthusten, Dyspnoe, ev. kreislaufinstabil, ev. Schock (Pat. versterben am Verstickten von Blut)	1. Inspektion Tonsillenlogen 2. ev. Laryngoskopie	> Hospitalisation:NOTFALL! 1. grosslumiges PVK (sofort), Testblut 2. Kompression (Tamponade, Finger) 3. Intubation (Gefahr Aspiration)	1. Naht 2. Ligatur A. carotis externa 3. Embolisation	Falls nur leichte Nachblutung (sog. Warnblutung) >Hospital. zur Überwachung (engmaschige Rachenkontrollen, grosslumiger Zugang), falls erneute Blutung OP